

Mity i krytyka koncepcji

Wokół „uzależnienia od porno” narosło wiele mitów — niektóre z NoFap, niektóre z tradycyjnej terapii uzależnień. Karta pomaga odróżnić, co ma dowody, co nie.

CZAS: 25 min Psychoedukacja krytyczna

ŹRÓDŁO: Ley i wsp. (2014); Prause & Pfaus (2015); Grubbs i wsp. (2020)

JAK UŻYWAĆ

Karta przedstawia **krytyczny przegląd** popularnych mitów wokół PPU. Pięć najczęstszych: 1) „każdy, kto ogląda porno, ma uzależnienie”, 2) „porno zmniejsza mózg”, 3) „NoFap daje superpowers”, 4) „porno powoduje dysfunkcje seksualne”, 5) „jedyna droga to całkowita abstynencja”. Karta nie zaprzecza, że PPU istnieje — pokazuje, gdzie nauka się kończy, a zaczyna ideologia lub komercja (np. sprzedaż blockerów, kursów).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Ley, Prause & Pfaus (2014, *Current Sexual Health Reports*) w przeglądzie systematycznym wykazali, że **wiele popularnych twierdzeń** o uzależnieniu od porno **nie ma poparcia empirycznego** lub jest oparta na metodologicznie słabych badaniach. Świadomość tego jest *ochronna* dla pacjenta: zmniejsza panikę, fałszywy wstyd i podatność na pseudonaukowe „leczenie”. Z drugiej strony — nie zwalnia z obserwacji własnego używania. **PPU jest realne** dla części osób (CSBD wg ICD-11), ale nie dotyczy każdego, kto czasem korzysta. Klucz: *indywidualna ocena* oparta na realnym funkcjonowaniu, nie na strachu wynikającym z mitów.

01 ✕ Pięć najczęstszych mitów

MIT 1 · „KAŻDY, KTO OGLĄDA PORNO REGULARNIE, MA UZALEŻNIENIE”

Co naprawdę wiadomo: według ICD-11 CSBD dotyczy 1–3% populacji ogólnej. Większość osób, które używają regularnie (kilka razy w tygodniu), *nie spełnia* kryteriów zaburzenia. Kryteria: utrata kontroli, klinicznie istotne cierpienie, dysfunkcja w jednym z głównych obszarów życia. *Sama częstotliwość* nie wystarcza.

MIT 2 · „PORNO ZMNIEJSZA OBJĘTOŚĆ MÓZGU / NISZCZY GO NIEODWRACALNIE”

Co naprawdę wiadomo: Kühn & Gallinat (2014, *JAMA Psychiatry*) wykazali *korelację* niższej objętości prążkowie z większą konsumpcją porno (n=64). To badanie *przekrojowe* — nie pokazuje, czy porno zmniejsza mózg, czy mniejsze prążkowie predysponuje do oglądania. Brak badań prospektywnych potwierdzających skrajny pogląd NoFap.

MIT 3 · „NOFAP (90 DNI ABSTYNENCJI) DAJE SUPERPOWERS”

Co naprawdę wiadomo: brak badań RCT potwierdzających przyrost testosteronu, atrakcyjności, koncentracji. Zerich i wsp. (2003): testosteron faktycznie rośnie po 7 dniach abstynencji, ale wraca do bazy. Realne korzyści (mniej wstydu, więcej czasu, lepsze relacje) są *realne*, ale opisuje je *codzienna psychologia*, nie mistyka.

MIT 4 · „PORNO POWODUJE DYSFUNKCJE SEKSUALNE (PIED — ANG. PORN-INDUCED ERECTILE DYSFUNCTION)”

Co naprawdę wiadomo: dane są *niejednoznaczne*. Park i wsp. (2016): tak, są kazuistyki dysfunkcji ustępujących po abstynencji. Prause & Pfaus (2015): w badaniach kontrolowanych nie potwierdzono związku przyczynowego. Najpewniejszy wniosek: *u części osób* może być relacja, ale daleka od „każdego, kto ogląda”.

MIT 5 · „JEDYNĄ DROGĄ JEST PEŁNA ABSTYNENCJA”

Co naprawdę wiadomo: u części pacjentów z ciężkim CSBD pełna abstynencja jest klinicznie wskazana. U innych — szczególnie z niespójnością moralną lub umiarkowanym używaniem — celem może być *integracja* seksualności, nie eliminacja. Decyduje to terapeuta z pacjentem, indywidualnie.

02 Co realne — pięć faktów

Fakt 1: CSBD (kompulsywne zaburzenie zachowań seksualnych) *istnieje* jako diagnoza w ICD-11 (WHO 2022) — uznane, badane, leczone.

Fakt 2: Tolerancja jest realna — używanie eskaluje w czasie u części osób (Voon 2014, Gola 2017).

Fakt 3: niespójność moralna jest częstym *źródłem cierpienia*, nie samego zaburzenia (Grubbs 2019).

Fakt 4: Terapia CBT i ACT mają udokumentowaną skuteczność (Hallberg i wsp. 2019, RCT n=110).

Fakt 5: Mózg uzależniony *się goi* po odstawieniu — z czasem wraca równowaga dopaminergiczna, samokontrola, zdolność czerpania radości z innych źródeł. Tempo: 3–12 miesięcy w zależności od stopnia.

03 Twoja krytyczna ocena

KTÓRE MITY KIEDYŚ WE MNIE BYŁY

— *skąd przyszły*

CO DZIŚ WIEM OSTATECZNIE

— *co już mi nie wmawiają*

MÓJ WŁASNY OSTROŻNY WNIOSEK O SOBIE

— *bez paniki, bez bagatelizowania*

04 Trzy zasady krytycznego myślenia o PPU

1 • Sprawdź źródło. Kto pisze?
Czy artykuł cytuje recenzowane badania, czy tylko anegdoty?
Reddit ≠ JAMA Psychiatrii.

2 • Sprawdź motyw. Czy ktoś sprzedaje kurs / blocker / suplement? Konflikt interesów wymusza ostrożność wobec twierdzeń.

3 • Sprawdź u siebie. Czy *moje* funkcjonowanie cierpi? Czy *ja* mam problem? To ważniejsze niż statystyki.

Klucz: Ley, Prause & Pfaus (2014) zwracają uwagę na fenomen *moral panic* wokół pornografii — falę wzmożonych obaw, nieproporcjonalnych do empirii. Świadomość tego daje *wolność*: pacjent może zająć się *swoim* realnym problemem, nie obciążając się dramatycznymi twierdzeniami o „*generacji zniszczonej przez porno*”. Z drugiej strony — sceptycyzm wobec NoFap nie znaczy zaprzeczenie problemu. CSBD jest realne, terapia działa, neuroplastyczność daje nadzieję. **Najlepsze podejście:** trzeźwa, indywidualna ocena oparta na realnym funkcjonowaniu, wsparta profesjonalną diagnostyką.